第六章 以人为中心的健康照顾

本章数字资源

学习提要

- 全科医学和全科医疗的基本特征之一是以人为中心的健康照顾，这就要求全科医生采用生物-心理-社会医学模式来开展全科的医疗、预防、保健、康复等卫生服务工作。
- 在诊疗工作中，全科医生首先要确认和解决病人的现患问题，同时对其健康问题进行管理，并为病人及其家庭提供疾病预防和健康促进的建议。
- 全科医生在开展卫生服务工作时应了解就诊者的健康信念，从而更好地维护和改善病人的健康。
- 以人为中心的健康照顾，又称为以病人为中心的照顾，与专科医疗以疾病为中心的诊疗模式相比，有着根本的区别。

全科医疗的照顾目标是维护服务对象的整体健康。为达成这一目标，全科医生在提供临床服务过程中须遵守以病人为中心的照顾这一原则，把病人看作有生命、有感情、有权利、有个性的人，遵循生物-心理-社会医学模式，在尊重和理解病人的基础上，正确认识和评价病人的健康问题，与病人及其家属共同商定处理方案，动员和利用各种资源为病人提供综合性、连续性、可及性、协调性和个体化的健康照顾。

第一节 | 病人与疾病——两个不同医学模式的关注中心

一、社会的进展与医生关注中心的演变

疾病和病人是两个完全不同而又密切相关的概念，是医生职责的两个中心范畴。病人是疾病的载体，但又不仅仅如此，病人除了具有疾病的生物学特征，还具有“人”的社会学特征。纵观医学发展史，随着医疗科技的发展，不同历史时期的医生对疾病和病人的认识不同，医生的关注中心也有明显的不同。

古希腊的先哲希波克拉底曾说过“了解你的病人是什么样的人，比了解他们患了什么病要重要得多”，可见古代的医生已经意识到关心患病的人比关心疾病本身更重要。事实上无论西方还是东方，古代医生都很注意对病人的全面观察，包括他们的出身、籍贯、经历、体质状况、人格特征、生活方式、家庭与社会环境、职业与经济情况等。我国的传统医学更是注重人的整体观察，整体观是中医的理论基础和临床实践的指导思想。整体观认为，人体是一个多层次的整体，构成人体的各个组成部分之间在结构上是不可分割的，在病理上是相互影响的，在功能上是相互协同的。人生活在自然和社会环境中，人体的生理功能和病理变化必然受自然环境、社会条件和精神因素的影响。整体观是古代唯物论和辩证法思想在中医学中的体现，要求人们在观察、分析、认识和处理有关生命、健康和疾病等问题时，注重人体自身、人与周围环境之间的统一性、完整性和关联性。

为什么古代医学家能采用这种朴素的整体观的哲学方法来指导他们的医学实践呢？这是由于古代医学无法用实验手段或先进的检查设备探知疾病的本质，只能借助于朴素的自然哲学来解释人体

和疾病。如中医的“阴阳五行学说”,其中阴阳学说是对自然界中相互关联而又对立的某些事物和现象的概括,是古代朴素的对立统一观;五行学说将事物和现象归为木、火、土、金、水五类,是古代原始的系统论。古人以此来阐述人的组织结构,概括人体的生理功能,说明疾病的病理变化并指导临床疾病的诊治。与此类似的有古希腊的“四元素学说”“四体液学说”和“体质学说”等。

自16世纪文艺复兴时代开始的一系列科学革命,包括人体解剖学、生物学、化学等学科的发展及显微镜的发明,使人们对人体和疾病的本质从系统、组织、细胞,甚至分子等不同层次加以认识,揭开了古代医学笼统模糊的面纱,显露出精确而清晰的现代医学的面目。医生们用大量的临床研究和科学实验去探索疾病的微观机制,医学的分支越来越细,医生的关注中心也自然而然地从病人转移到疾病。应当说这是科学发展的结果,医学进步的必然。

二、生物医学模式——以疾病为中心

医学模式是指医学整体的思维方式,即解释和处理医学问题的方式。文艺复兴时代发展起来的生物医学模式(biomedical model)把人作为生物体进行解剖分析,力图寻求每一种疾病特定的生理、病理变化,研究相应的生物学治疗方法,因此疾病是这一模式的关注中心。

建立在生物科学基础上的生物医学模式认为:每一种疾病都应从器官组织或细胞,甚至从分子水平寻找到可以测量的形态学或化学改变,都能够确定特定的病因。因此形成了以疾病为中心的健康照顾。生物医学模式运用定量研究方法,具有客观性及科学性,该模式的理论方法简单直观,易于推广。医生的关注点集中在疾病,力求利用高科技的检查方法和大量客观实验数据来诊断疾病,通过药物、手术等方法治疗疾病。在医学发展史上作出了巨大的贡献,推动了整个医学历史的发展。然而随着医学科学发展和疾病谱改变,以疾病为中心的健康照顾逐渐暴露出明显缺陷。①以疾病为中心,忽视病人的需求:只关注就诊者的症状和体征,并以有无生物学疾病作为评价病人健康状况的标准,对于病人心理和社会方面的问题(如生命质量),则不予评价,造成医生只重视疾病的诊治,却忽略了病人的主观感受和需求,致使诊疗过程机械化和失人性化。②医患关系疏远,病人依从性降低:在生物医学模式中,医生忽视了病人的主观能动性。病人不能参与诊疗方案的选择,也不被告知所患疾病的原因和接受治疗措施的理由,仅仅被动地接受医生的检查和处理。医生的关注重点在于疾病的病理、生理变化,而对于疾患和诊疗措施给病人带来的主观感受,以及病人自身的心理、情绪变化对疾病的影响则有所忽略。这种对疾病的热衷和对病人本身的忽略,致使医患关系疏远,也必然导致病人依从性降低。③医生思维的局限和封闭:生物医学模式中,医生的思维局限于生理疾病,强调症状、体征和实验室检查的客观意义,而忽略了与病人密切相关的人格、个人经历、经济情况、家庭和社会支持等因素。这种局限封闭的思维方式忽视了心理、社会因素对疾病的影响,必然导致促进健康的干预措施收效甚微。

在人类历史发展的长河中,生物医学模式的确对促进人类健康作出了不可磨灭的贡献,但其无法解释没有疾病时的种种身心不适,无法解释生物学与行为学的相关性,也无法解决慢性病病人身心疾患和生活质量降低等问题。由于自身的缺陷、社会发展和疾病谱的改变,生物医学模式不再适应公众对健康的需求。因此人们更需要一种人性化的、能使人的健康得到全面照顾的医学模式。

三、生物-心理-社会医学模式——以人为中心

(一)生物-心理-社会医学模式是人类医学发展的必然趋势

人类社会发展初期,严重的急性传染性疾病横行,直到20世纪中期以前,影响人类健康的主要疾病仍是各种传染病和营养不良。随着经济的发展、生物医学防治手段及公共卫生的普及,在现代工业化社会中,早期主要由传染病和营养不良所导致的死亡明显减少,而慢性非传染性疾病愈来愈常见。再后期,由于现代经济社会的建立,心理和社会压力开始成为疾病及就诊的主要原因,生活方式不良和疾病行为成为人类健康的突出问题。全球死因三大主要疾病,缺血性心脏病、脑卒中和慢性阻塞性

肺疾病，均包含一定的心理和社会因素，如生活压力、心理紧张、环境污染、不良生活方式等。至于公害、交通事故、酗酒、饮食过度、自杀、吸毒、犯罪率升高和家庭瓦解，则更是许多心因性疾病的心理社会因素。人们逐渐认识到仅以解剖学、生理学、生物化学和微生物学等生物科学和器官、组织、细胞乃至基因等的改变来解释疾病、防治疾病已远远不够，必须把人作为包括自然环境和社会环境在内的生态系统的组成部分，从生物、心理、社会的水平综合考察人类的健康和疾病，并采取综合性措施防治疾病，促进人类健康。19 世纪以来，随着预防医学、流行病学、心理学、医学哲学和医学社会学等研究领域的发展，新的医学模式——生物-心理-社会医学模式（bio-psycho-social medical model）应运而生。

（二）病人的宏观和微观世界

病人不仅是指患某种疾病的人，还包括有健康问题而需要医务人员帮助的社会成员。病人首先是人，是在特定环境中从事物质生产活动和精神文化活动并能表现自己独特个性的存在物。自然性和社会性是人的两种根本属性：人首先具有自然性，由自然物质如蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质等分子组成的细胞、组织、器官和系统等构成，最终又被分解成这些物质回归自然，这些自然物质构成了人的微观世界（microworld），是生物医学可以采用自然科学的方法加以研究、量化和精确测定的；其次，人有其社会性，即作为社会存在的人具有特定的背景，包括个人背景、家庭背景、社区背景，乃至社会背景等，每个人还有特定的社会关系，包括人与人，人与家庭、社区、社会、国家，人与生态环境等诸多关系，人的社会性受法律、道德、文化、宗教、经济等诸多因素影响。人的特定背景和各种关系构成了人的宏观世界（macroworld），属于心理学、社会学、经济学、伦理学、法学和人类学等许多社会科学的研究范畴，是一个复杂的、多元的、难以量化的世界。人存在于自然和社会所组成的生态系统之中，处于宏观世界和微观世界的焦点。人所处的宏观世界与其自身的微观世界是相互联系、相互作用的，任何世界中的变化都会对人的健康产生重大的影响。生物-心理-社会医学模式认为，人的生命是一个开放系统，其健康状况是由与周围环境（包括自然环境和社会环境，即宏观世界）的相互作用，以及系统内部（微观世界）的调控能力决定的。医学的目的是维护人类健康，提高人类生命质量，因此，医学除了要关注疾病这一生命科学领域所研究的微观世界，还要关注人文社会科学等领域所研究的人的宏观世界。病人是既具有疾病特征（微观世界），又具有社会文化背景（宏观世界）的个体，是具有其独特个性的人（图 6-1）。

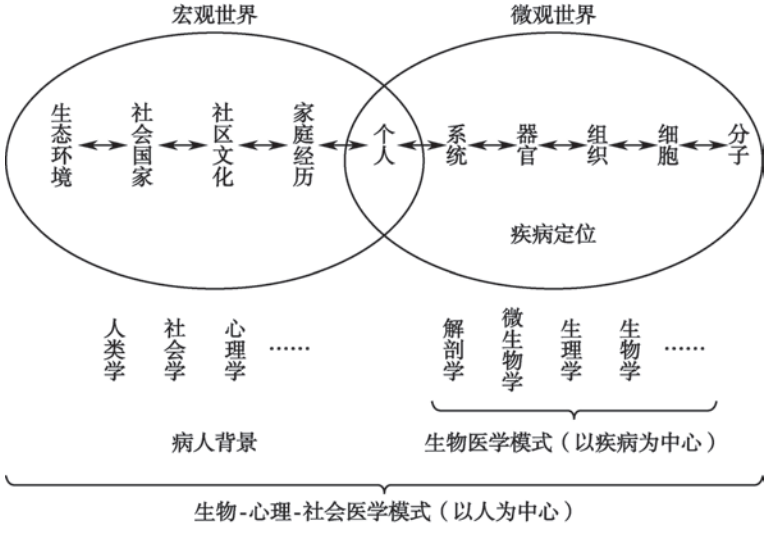


图 6-1　病人的宏观世界和微观世界

因此，医学和作为医学研究者、实施者的医生应该立体、完整地看待健康问题，在生物医学知识基础上，将病人看作是一个有思想和情感的社会人，为其提供以人为中心的健康照顾（person-centered care）。

NOTES

（三）以人为中心的健康照顾的基本点——进入病人的世界，了解人的个性

在生物医学模式中，病人是一架待修理的机器，疾病是这架机器上损坏的零件，医生是负责修理各种零部件的工程师。在这种医学模式下，与病人相脱离的疾病成为医生关注的重点，医生以是否有生物医学的疾病来评价与病人有关的健康问题以及问题是否严重。生物-心理-社会医学模式则是以人的整体健康为最终目标，疾病是病人的一部分而非全部，病人的需求和期望与生理疾病同等重要。全科医生在提供以人为中心的健康照顾时需要进入病人的世界，了解病人的宏观和微观世界，同时了解病人的个性。病人是一个身心统一的整体，是具有生理功能和心理活动的生物体，病人的精神和躯体是不可分割的，是生命活动中相互依赖、相互影响的两个方面，共同作用于机体的健康。因此，全科医生不仅需要了解病人的病理、生理过程，还需要了解病人的心理过程。另外，每个人都有其独特的个性和社会背景，这些也将对健康产生影响。如果不了解病人的个性、背景和关系，就不可能完整地认识病人，也就无法全面了解和理解病人的健康问题，更不用说解决这些问题了。进入病人的世界、了解病人的个性是以人为中心的健康照顾的基础。全科医生应采取以病人为中心的态度，通过对话与交流，了解病人的背景，进入病人的宏观世界，发挥其主动性，从而达到促进健康、提高生命质量的目的。在这一过程中，全科医生不是作为一个旁观者或指挥者，而是作为与病人处于平等地位的医患互动模式的一部分而发挥作用。

（四）全科医生的“病人”范畴

1.“疾病”“病患”和“患病”的不同 英语中与疾病有关的词汇很多，其中“disease”“illness”和“sickness”最为常用。在英汉辞典中多译为“疾病”，然而现代医学心理学和医学社会学等学科通过对与人类疾病相关的各种情况的研究，将这 3 个词的词义区分开来，用以描述 3 种不同的情况，表达 3 种不同的状态。

“disease”译为“疾病”，是医学术语，指可以判明的人体生物学上的异常情况，可以根据体格检查、化验或其他特殊检查加以确定。

“illness”译为“病患”（有病的感觉），指一个人的自我感觉和判断，认为自己有病。可能确实患有躯体疾病，也可仅仅是一种心理或社会方面的失调。

“sickness”译为“患病”，指一种社会承认，即他人（社会）知道此人现处于不健康状态。

一个人可能有明显的“病患”，如胸闷、心悸，但却查不出什么“疾病”，他如果因此就医或告诉他人，就会被认为是“患病”了，被别人视为“病人”。而一个人可以有严重的“疾病”，如早期肝癌的病人，他未觉得有什么不适，即并无“病患”，因而未就医，别人也不知情，因此没有人知道他“患病”，他也不被别人视为“病人”。一旦癌症进展，出现症状（病患）而就医，确诊为肝癌（疾病），那么他就“患病”了。由此可见，这 3 种情况可以单独、同时或交替存在（图 6-2）。

“以疾病为中心”的生物医学模式仅强调“疾病”的地位，忽视了“病患”和“患病”这 2 种情况，而“以病人为中心”的生物-心理-社会医学模式则强调对这 3 种情况同等对待。全科医生应当从 3

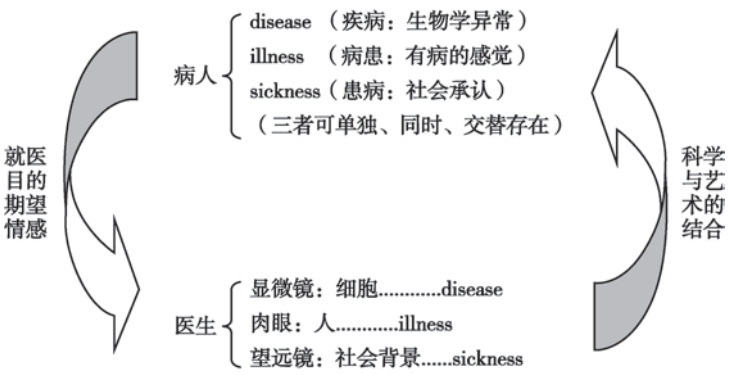


图 6-2 病人的需求和医生的视觉角度

种视觉角度来看病人：用显微镜检查病人身体、器官上可能的病灶；用肉眼审视病人，了解其病患的体验；还要用望远镜观察病人的身后，了解与其患病有关的社会背景情况。这样，全科医生就具备了“立体的”或“全方位”的思维方式，并将其与病人的 3 种情况联系在一起。全科医生在日常诊疗过程中只有提供高度科学性和艺术性的负责式服务，才能胜任自己的工作而赢得服务对象的信任。

2. 全科医生的责任和面临的挑战　在以专科为主的综合性医院中，专科医生接收、处理的多为疑难、危重病人，而在基层工作的全科医生面对的是常见病、慢性病、轻症病人以及健康人群。服务对象的不同决定了全科医生不仅是对病种或知识技术负责，更必须对人负责。全科医生所要处理的并不局限于健康问题的类型，甚至不局限于严格定义上的健康问题。全科医生不会因为疾病的治愈、疗程的结束或疾病的不可治性而中止服务。因此，全科医生必须与服务对象建立互动式的医患关系，提供个性化的服务或称个性化的照顾（personalized care）。疾病作为一种病理、生理现象，有其自身的发生、发展和转归过程，在这个过程中病人的人格、经历、心理、家庭、社会关系，乃至生态环境都与疾病息息相关。全科医生应当了解疾病和病人的全部，熟悉服务人群的生活习惯、环境因素和人文地理等，从而能够有的放矢地开展工作。全科医生的责任在于维护其服务人群的健康、提高其服务人群的生命质量，这就更要求全科医生有群体观念，其实践应着眼于人群，而不仅仅是病人个体。举例来说，全科医生不仅要关注前来治疗高血压的病人，同时还要关注未做过血压检查的人。生物医学模式采用客观和实证主义方法，而生物-心理-社会医学模式则要求全科医生不但要重视这种客观现象，更要重视服务对象的主观感受，重视病人的生命质量。基层医疗保健是社会医疗保健体系的门户和基础，全科医生就是这一门户的“守门人”，也是卫生资源的管理者。因此，全科医生应具有预防医学观念和卫生经济学观念，通过预防疾病和杜绝浪费，使有限的卫生资源得到合理的使用。

在基层工作的全科医生所服务的对象包括病人、所谓“亚健康”人群和健康人群，不同群体有着不同的医疗保健需要。全科医生必须根据服务对象的不同需要提供相应的预防、保健、医疗、康复等服务。

（1）无疾病时（发病前期）：提供预防保健，包括特异性疾病的预防措施和非特异性的健康促进，如健康咨询、生活方式指导、关系协调等整体性照顾，防止疾病的发生（一级预防）。

（2）症状早期，疾病尚未分化（临床前期或发病早期）：医生应具有较高的警惕性，能识别问题，早查早治，提供适当干预措施，以控制疾病的发展和恶化（二级预防）。

（3）疾病确诊时（临床期或发病后期）：减少并发症和后遗症，避免残障，提供康复和临终关怀服务。特别对于一些不可治愈的慢性病，医生应充分理解病人的患病体验，了解其社会背景、人生观和价值观；建立互动协作式的医患关系，提高病人依从性，制订长期管理计划、提高管理质量（三级预防）。

由此可见，全科医生面临的是建立和发展一种综合的、整体的、持续的和个性化的卫生服务模式，此类服务要求全科医生既要了解疾病，更要理解病人。

第二节 | 以人为中心的健康照顾

一、全科医生应诊的主要任务

Stott 和 Davis 于 1979 年提出全科医生在应诊中的 4 项主要任务，包括：①确认和处理现患问题；②管理连续性问题；③适时提供预防性照顾；④改善病人的就医遵医行为。其充分体现了全科医疗的主旨，即为人们提供基本的、个体化的、持续的、全面综合的医疗服务。

（一）确认和处理现患问题

确认和处理现患问题（present problem）是全科医生应诊时的核心任务（图 6-3）。病人大多因近期感觉身体某一部位不适或由此怀疑患上某种疾病而到诊所就医，全科医生在详细采集病史后应分

析其就诊原因。如糖尿病病人，因近期出现口干、体重下降而前来就医，全科医生首先要通过血糖检测判断病人的症状是否由血糖升高引起，并给予适当处理。如果仅从糖尿病专科角度来看，给予或加强糖尿病药物治疗就可以了。全科医生除了处理高血糖这个问题，还要探索在血糖升高背后潜藏的其他原因，如是否有生活中的压力，最近情绪如何，是否坚持服药等，病人对这一问题的顾虑是什么，希望医生给予什么样的帮助等。

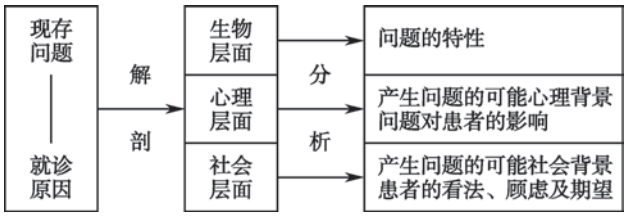


图 6-3 以生物-心理-社会医学模式确认现患问题

全科医生必须具备并在应诊中体现出这种从疾病本身出发，同时从心理、社会的多角度和多层面解剖、分析病人就诊原因的思维方式，对病人进行全方位的关怀和照顾。

（二）连续性问题的管理

社区常见慢性疾病如糖尿病、高血压等，与遗传、情绪及生活方式有着密切关系，不仅需要长期使用药物以及非药物的方法予以控制，同时需要关注这类疾病对病人远期健康的不良影响，如糖尿病并发症、高血压靶器官损害等。因此，全科医生除在应诊时处理病人的现患问题，还应对连续性问题如慢性疾病等进行长期管理，与病人一起制订长期管理目标，指导病人改变生活方式，定期随访血糖、血压，定期进行糖尿病并发症和高血压靶器官损害的筛查等。社区中类似糖尿病、高血压这样的慢性疾病很多，严重威胁着人们的健康，而每一次短暂的应诊是不可能妥善解决这些问题的。因此，全科医生需要给予病人全面的、持续性的照顾，这种持续性的医疗照顾涵盖人生的各个时期、疾病的各个阶段及各种急性或慢性的健康问题。

（三）适当的预防性照顾

糖尿病、高血压等慢性疾病若得不到有效控制，将导致冠心病、脑卒中、肾衰竭等严重并发症，吸烟、高脂肪摄入、生活不规律等不良生活方式可促使这些并发症的发生。全科医生对出于不同原因来就诊的病人，应充分体现预防观念，将预防措施视作日常诊疗中应执行的工作，主动评估危害健康的各种因素并加以处置。这种预防性照顾（preventive care）在全科医疗中占有相当重要的地位，包括计划免疫、健康促进、发病前期乃至发病期的诊断与治疗。只有防患于未然，才能给人们带来真正的健康。

（四）改善就医遵医行为

在利用医疗服务的问题上，病人往往存在不恰当的行为方式。就医过多反映了病人敏感紧张或依赖的心理；就医过少可能是因为病人健康意识不够或经济条件有限；缺乏良好的遵医行为更使得医生的医嘱形同虚设。因此，教育、启发病人何时就医，寻求何种层次、类型的医疗机构，如何加强自我管理也是全科医生的重要任务。

二、以病人为中心的接诊模式

1983 年 Berlin 和 Fowkes 共同提出 LEARN 模式，目的在于避免由于文化背景及社会地位不同导致医生与病人对于疾病及其症状的解释模式存在差异而无法建立良好的医患沟通，进而影响疾病的诊断、治疗效果及依从性，或引发医疗纠纷等。此模式更加尊重病人本身对疾病的认知与理解，重视病人的表达与对疾病处置的看法，将其应用于全科医疗的接诊过程中更能体现以病人为中心的健康照顾理念。

所谓 LEARN 模式，就是整个接诊过程经历 5 个步骤：①全科医生要先站在病人的角度倾听（listen），收集病人所有的健康问题及其对健康问题的认知或理解；②详细收集所有可供疾病诊治的资料后，医生须向病人及其家属解释（explain）对上述健康问题的诊断或看法；③在说明病情后，要容许（acknowledge）病人有机会参与讨论，沟通彼此对病情的看法，使医患双方对健康问题的看法趋于一致；④医生按所达成的共识向病人提出最佳或最合适的健康教育、检查及治疗建议（recommend）；⑤如病人对检查及治疗建议存在疑惑，医生需要与病人进一步协商（negotiate），最后确定医患双方皆

NOTES

可接受的方案（表 6-1）。

表 6-1　以病人为中心的接诊五步骤（LEARN 模式）

英文字头	英文字义	中文字义	定义与内容
L	listen	倾听	• 倾听不仅是传统意义上所指的专心听、用心听、不插话及与病人要有目光接触等，最重要的是以开放式的问句形式询问病史，让病人有机会表达疾病发生的始末，从而收集到病人未说清楚或一时忘记的症状，并发现症状背后的问题所在 • 要“会问问题”，有好的问题引导，病人才能提供医生所需的病情资料，表述自身对所患疾病的症状、原因、过程及预后的看法；医生也才能收集到有助于正确诊断与治疗的完整信息 • 若病人有相关就诊经历，还要询问就医的经验、就医的动机和过程，以及曾接受过的检查、治疗方法与疗效，作为本次诊断及治疗的参考 • 从广义角度来说，体格检查的发现、病人的初步检验结果与病人既往的病史记录等信息资料都是诊断病情所需要的，均可归为倾听的范围
E	explain	解释	• 收集到完整的病史资料后，医生应遵循生物-心理-社会医学模式，采用病人可以接受的通俗用语，解释说明疾病可能的诊断及病因
A	acknowledge	容许	• 医生解释病情后，应询问病人有无疑问，以了解彼此对病情的看法是否存在差异 • 当医患双方的看法存在不同时，须进行必要的处理或解释说明，消除彼此间的认知差距；病人有误解时，应进一步寻找例证，说服其接受医生的看法；若病人的看法无碍治疗方向，就应尽量尊重病人的想法，据此处理问题
R	recommend	建议	• 在了解彼此对疾病的认知后，医生应兼顾病人的主观看法及疾病医疗的合理性，提出具体的检查及治疗计划并详细告知病人；让病人参与制订治疗计划是疾病处理中非常重要的一环，可增加病人对治疗计划的依从性
N	negotiate	协商	• 最后须询问病人对医生建议的检查及治疗计划有无疑问，以便医患双方进一步协商，让病人充分理解并接受疾病的诊疗过程

在 LEARN 模式的 5 个接诊步骤中，第一个步骤“listen”、第三个步骤“acknowledge”及第五个步骤“negotiate”，都能让病人充分表达自身意见，而第二个步骤“explain”与第四个步骤“recommend”也都参考病人的意见而提出解释或处置，因此这 5 个步骤充分体现了以病人为中心的接诊过程。

三、全科医疗的问诊方式

我国社区卫生服务中心的任务是集医疗、预防、保健、康复、健康教育及优生优育为一体的，而作为团队核心的全科医生，工作十分繁忙，在接诊生理、心理和社会背景均不同的病人时，亟须一个简明且系统的问诊方式，以便迅速掌握病人生理、心理、社会问题的核心。1986 年，Stuart 和 Lieberman 首次推出 BATHE 和 SOAP 两种开放式的问诊及记录格式。

（一）BATHE 问诊方法，强调从背景、情感、烦恼、处理、移情五个方面收集病人信息。

B（background）——背景，了解可能导致病人患病的心理或社会因素。

A（affect）——情感，了解病人的情绪状态。

T（trouble）——烦恼，了解问题对病人的影响程度。

H（handling）——处理，了解病人的自我管理能力。

E（empathy）——移情，对病人的问题表示理解，从而使其感受到医生的支持。

（二）SOAP 问诊方式，从病人就诊的原因、想法、顾虑、期望四个方面了解病人的问题及需求。

S（support）——支持，把问题尽量正常化、普通化，避免引起病人的恐惧。

O（objectivity）——客观性，以科学、客观的态度对待病人的问题，以及鼓励病人辨清问题的现实性，引导其客观对待现实问题，并给予其希望。

A（acceptance）——接受，鼓励病人接受现患和其他情况，帮助其树立乐观态度。

P（present focus）——关注现在，鼓励病人关注当下，做好现在要做的每一件事。

第三节 | 健康信念模式与健康照顾

一、健康的概念

世界卫生组织关于健康的定义为："健康是一种在身体上、精神上的完满状态，以及良好的适应力，而不仅仅是没有疾病和衰弱的状态"。一个人在躯体健康、心理健康、社会适应良好和道德健康四方面都健全，才称得上是一个完全健康的人，简而言之就是身心健康。①躯体健康：一般指人体生理的健康。②心理健康：首先指具备健康心理的人，其人格完整、自我感觉良好、情绪稳定，积极情绪优于消极情绪，有较好的自控能力，能保持心理上的平衡，有自尊、自爱、自信及自知之明；其次，在自己所处的环境中有充分的安全感，能保持正常的人际关系和进行人际交往；再者，对未来有明确的生活目标，能切合实际、不断进取，有理想和事业的追求。③社会适应良好：指一个人的心理活动和行为，能适应当时复杂的环境变化，为他人所理解和接受。④道德健康：不通过损害他人利益来满足自己的需要，有辨别真伪、善恶、荣辱、美丑的是非观念，能按社会道德规范的准则约束、支配自己的行为，能为他人的幸福作贡献。

二、健康信念模式在健康照顾中的运用

（一）健康信念模式

不同的人对健康的认识不同，因而对健康的关注程度也不同。大多数人只有在患病或患重病（如心肌梗死、恶性肿瘤等），即将失去健康时才认识到健康是第一位的，这就涉及人们的健康信念模式问题。

健康信念模式（health belief model）是运用社会心理学方法解释健康相关行为的理论模式。此模式在 20 世纪 50 年代提出，主要用于预测人的预防性健康行为和实施健康教育。健康信念，即人如何看待健康与疾病、如何认识疾病的严重程度和易感性、如何认识采取预防措施后的效果和采取措施所遇到的障碍，其在人们是否会采取疾病预防措施中起着十分重要的作用。

健康信念模式提出，针对某种临床疾病，影响人们采取相应预防保健措施或消除危害健康行为的因素如下。

1. 对疾病的严重程度和易感性的认识 对疾病严重程度的认识是指个体对罹患某种疾病的严重性的看法，包括人们对疾病引起的临床后果的判断，如死亡、伤残、疼痛等；对疾病引起的社会后果的判断，如工作烦恼、失业、家庭矛盾等。认识到某种疾病的严重性关系到一个人是否采取预防保健措施。一名罹患大肠癌的病人，如果他意识到大便不成形是个危险信号，并且大肠癌会产生非常严重的后果，他就可能因为这个症状而去就医；另一名病人认为大便不成形是非常轻微的症状，没什么关系，那他就不会去就医。人们认识到如果不采取健康保健行动就可能会患严重疾病，那便会选择采取相应的积极行动。对疾病易感性的认识是指个体对罹患某种疾病可能性的认识，包括对医生判断的接受程度和自身对疾病发生、复发可能性的判断等。病人对某种疾病易感性的认识程度是指针对某一疾病，个人感觉自己可能患上该病的可能性有多大。人们对疾病易感性的认识常常和他们患该病的实际风险不完全一致。如，吸烟者可能自己意识不到患肺癌的危险；实际上与非吸烟者相比，吸烟者罹患肺癌的风险显著增高。事实上，人们对某个健康问题越感觉自己易感，就越有可能采取保护行动。

2. 采取相应预防措施的利弊得失以及采取行动所存在的障碍 这是指如果采取了健康保健的行为，能获得什么样的益处。人们在面对健康问题做抉择的时候，经常会衡量该决定可能的益处和可

能不利的方面。人们只有认识到所采取的行动能够成功保护自己，而不受所担忧的健康问题的困扰，才会去行动。如，糖尿病病人在选择治疗措施时就会考虑到，饮食控制和药物治疗都可使血糖下降，这是两种治疗措施所带来的共同的益处。但饮食控制意味着需要放弃很多品尝美味的机会，药物治疗将会带来药物的副作用，这是不同治疗措施各自的弊端，也是选择治疗方式时的障碍所在。人们会权衡两者的轻重，从而作出选择。正面的益处，对于接受一项预防措施是非常重要的；同样，行动的阻碍对于人们是否会采取某种行为也有巨大的影响。

3. 病人采取行动的可能性　这是指病人认为自己采取某项预防保健行动的能力，或认为自己采取该行动的可能性。如果病人在考虑医生提出的健康建议前就认为自己不可能遵循这样的意见，当然就不会采取相应的行动。这种对自己能力或采取行动的可能性的低估是采纳健康保健意见并付诸行动的主要障碍之一。

4. 将思想转化为实际行动的触发因素　尽管病人对某个健康问题已经具备了一定的认识，但在真正付诸行动前常常有一个触发因素。如病人某一天突然前来就医，希望就戒烟等改变自己生活方式的行为求助于医生。原来他的一个好朋友与他情况类似，数日前突发心肌梗死住院抢救。该实例就是这位病人要求采取预防保健措施的触发因素。

媒体的宣传、亲友患病、医生的告诫、他人的建议等，都可能成为改变行为的触发因素。这些触发因素可提高病人对自己罹患疾病易感性的认识、对疾病严重程度的认识以及对采取行动获益的认识，降低所存在的不利因素和行动障碍对行动的影响，增强病人改变自己行为的自信心。

从病人角度更加简单地说就是：

（1）我会得这个病吗？

（2）这个病会严重到何种程度？

（3）采取某种行动是否容易或很难？采取行动我将付出什么代价？

（4）我的行动能否使我的健康有所改变？

（5）那好吧，现在我开始采取行动了！

（二）健康照顾

社会各阶层的群众因其社会角色、经济状况、文化水平、受教育程度以及来自家庭、社会的不同影响，对健康有着不同理解。现阶段有一种普遍错误的观点，认为没有疾病就是健康，即使患病但没有相应症状就是健康。全科医生在接诊时，除了诊治疾病，还需要了解病人的健康信念、就医行为和遵医嘱性。

【案例】 男性，38 岁，农村进城务工人员，在酒店做厨师工作 12 年。吸烟史 20 年，30 支/天。因反复头晕 2 个月来就诊，检查结果为血压 160/100mmHg，体重指数（BMI）29kg/m^2，有高胆固醇和高甘油三酯血症，空腹血糖 6.6mmol/L。下面是他与医生之间的对话。

医生：“您的检查结果出来了，您有高血压和高血脂，血糖也偏高，需要治疗。”

病人：“我的头晕和高血压有关吗？”

医生：“我认为是的。”

病人：“那您给我开点药吧。”

医生：“药物治疗是需要的，但首先是需要改变您的生活方式，因为健康的生活方式是控制血压的先决条件；此外，您还有其他的问题需要关注，包括‘高血脂、高血糖、肥胖’等，患糖尿病的风险比一般人高，因此要增加运动、控制饮食、减轻体重，菜不要吃得太咸，要戒烟，生活起居要正常。”

病人：“血脂高是什么意思？您说我可能得糖尿病，不可能！我爸爸有高血压，我听说高血压有遗传，我现在也有高血压了，高血压我得好好治疗，我爸就是高血压脑卒中去世的。可我家没有人患糖尿病，我怎么可能会得糖尿病呢！”

医生：“血脂高是指您血液中的脂肪成分高于正常人，血脂增高的人容易发生动脉粥样硬化，也就容易发生心肌梗死和脑卒中，导致多器官受累，因此需要控制血脂水平。另外，尽管糖尿病和高血压

一样有遗传倾向，但没有家族史的人也可能得糖尿病。您目前的血糖已高于正常水平，虽然尚未达到糖尿病诊断标准，但您已经处于糖尿病前期状态，也就是说如果不采取措施，以后发生糖尿病的概率大大增加，而且血糖高的人也容易发生冠心病和脑卒中。”

病人：“除了头晕，我吃得下、睡得着、能工作，挺健康的。再说我做这个工作，上午开始忙到半夜，回去就想睡觉，根本不想动了。我知道抽烟不好，但和我一起工作的人，从老板到伙计都抽烟，不抽烟好像有点另类。说到减轻体重，我来这工作后体重增加了很多，也试过减肥，但是没用！”

医生：“我很理解您的处境，但吃得下、睡得着并不等于您是健康的，要是等到吃不下、睡不着那问题就严重了。我们再商量一下您的治疗方案吧……”

围绕上述案例，全科医生将健康信念模式运用于以人为中心的健康照顾需要解决几个问题。

1. 人们是否知道自己有罹患某种疾病的风险？或者人们是否对该病的严重性缺乏认识？

案例中的病人，他并不认为自己会得高脂血症和糖尿病，也不知道这两种疾病会对他的健康带来什么样的不良后果，因此他并不认为采取医生的健康建议有多重要。但是他知道因为自己父亲有高血压，自己也很有可能患高血压，而且也了解到高血压会引起脑卒中，便对血压控制采取了积极的应对方式。因此，全科医生首先应当根据人们发生健康问题的可能性和严重性给予有针对性的健康照顾。

2. 人们是否感到采取某一健康保健行动有困难，或者要付出的代价太大？

案例中的病人虽然知道吸烟有害，但他感到戒烟有困难，因为戒烟有可能影响他的人际关系，甚至影响工作，因此觉得自己戒烟的可能性很小。全科医生在进行健康照顾时，需要感知人们在采取相应预防保健措施或消除危害健康行为的过程中所面临的困难，帮助人们克服困难、战胜困难。

3. 人们是否缺乏兴趣？或者人们认为即便采取行动也不会有什么改变？

案例中的病人由于曾尝试减肥但未获得成功，因此对医生提出的减轻体重建议没有兴趣。全科医生在提出健康建议时，需要把这些健康行动的可能获益告诉病人。这种获益可以是近期的，如血压、血糖的下降；也可能是远期的，如心血管事件发生风险的降低，并以病人能感受到的近期获益来鼓励其坚持健康行动，以获得远期的良好效果。

4. 是否缺乏触发因素促使人们采取行动？

案例中病人的父亲死于高血压脑卒中，这就成为他一旦发现自己高血压就愿意积极治疗的触发因素。全科医生常常可以遇到这样的病人，他们由于媒体的宣传，或亲友患病而前来就医，以明确自己是否有类似的健康问题。不管其就医动机是否恰当，但媒体的宣传或亲友患病的确成为其采取行动的触发因素。全科医生可适当寻找和运用这样的触发因素，指导人们将健康的信念最终付诸促进健康的行动。

因此，全科医生在以人为本、以病人为中心的照顾中，需要了解、探究病人的健康信念；根据病人的具体情况，理解他们的客观需要和主观愿望，通过协商制订医患双方都能接受的健康目标；帮助、鼓励、引导病人采取最有利于其健康的行动，以达到真正的、全面的健康照顾。

（陈 红）

思考题

1. 举例说明全科医生在应诊时的主要任务是什么，全科医生的问诊有什么特点。
2. 体现以病人为中心的接诊过程，应包括哪些具体步骤？
3. 全科医生应如何提供以人为本的健康照顾？

思考题解题思路　本章目标测试　本章思维导图